

¿CÓMO AYUDAR A SUPERAR EL DUELO DE NIÑOS Y ADOLESCENTES – Y ADULTOS – FRENTE A LA MUERTE INTEMPESTIVA DEL PADRE O MADRE O TUTOR DE DESARROLLO, A CAUSA DE LA COVID’19?

27 de Agosto del 2020

Abilio López Pérez

El **duelo**, desde la reflexión psicoanalítica, es necesario para despedirnos dolorosamente y, a la vez, amablemente de quien se ha sido¹ y a quien nunca se olvida, pues su presencia queda registrada de manera indeleble en la memoria. Pero, a la vez, el duelo rompe una atadura que nos fija al pasado y nos impulsa a vivir el presente y construir el futuro con conciencia, responsabilidad y libertad.

La **melancolía** es la cara opuesta del duelo: nos cierra el futuro, no nos deja vivir el presente, nos ata al pasado con recuerdos recurrentes de angustia, ansiedad y, con frecuencia, de autoculpabilidad.

En estos días, conocemos a mucha gente, familia y amigos muy cercanos a nosotros que están padeciendo la tragedia de la muerte de un ser querido y tienen la herida abierta. Niños y adolescentes que han quedado abrupta e inesperadamente huérfanos. Para todos ellos escribo, con el fin de ayudarles no a sanar la herida de cualquier forma, sino a superar el trauma a través de un duelo resiliente.

He encontrado un trabajo de una investigadora sobre el duelo en niños. Sus reflexiones y aportes nacen de la contemplación de 51 niños que han padecido en edad temprana y de manera traumática la muerte de uno de los padres o de los dos.

Pero sus aportes iluminan el quehacer posible de los adultos consigo mismos, de los padres sobrevivientes y de los tutores de desarrollo (quienes se hacen cargo del desarrollo de los niños) y de los tutores de resiliencia (pueden ser profesionales de apoyo, generalmente personas que son referencias afectivas de los huérfanos sin ser psicólogos ni educadores especialistas; incluso amigos de los niños y vecinos de la calle; pueden ser también espacios alternativos como escuela o iglesia, y cosas como libros y juegos...).

Lo presento a continuación, en dos partes.

La primera es una dedicatoria y una introducción elaborada por mí, no necesaria para entender la segunda parte, pero la que recojo las razones y situaciones confluyentes que me han llevado a ofrecer el artículo que presento en la segunda parte.

El trabajo de investigación de Hélène Romano, que presento en la segunda parte, lleva como título ¿Cuáles son las fuentes de resiliencia para bebés y niños pequeños en duelo por la muerte de un ser querido? No está ni al pie de la letra, ni completo. He abreviado (...) contenidos o citas que no me parecían relevantes y he introducido entre paréntesis enlaces y explicaciones que considero pertinente.

Pueden compartirlo con libertad, hacerlo llegar a quienes ustedes consideren que lo necesitan....

¹ No sólo personas que se han ido producen dolor y trauma. También la pérdida de condiciones, situaciones construidas y cosas queridas, dejan huellas traumáticas.

I.- HACIA LA CON-VIVENCIA DE UN DUELO CAPAZ DE RESILIENCIAR EL TRAUMA PRODUCIDO POR LA MUERTE DE UNA PERSONA CERCANA POR COVID'19

Abilio López Pérez
27 de Agosto del 2020

In memoriam a los amigos y conocidos arrebatados por la Covid 19, a sus familias e hijos.

A mis hermanas y hermano: Mary, Merce, Gelines, Jovi.

A mis amigas Sarina y Ana.

A mi comadre Mailin.

*Y, en ellos y ellas, a todas las familias
que hoy lloran la ausencia de un ser querido arrebatado por la Covid,19*

*No hay nada más sencillo que la definición de la resiliencia: **la continuación de un nuevo desarrollo después de un trauma psíquico**. La definición de resiliencia es simple y está ampliamente aceptada: pero las que resultan más difíciles de descubrir son las condiciones que permiten iniciar un nuevo desarrollo después del trauma (Boris Cyrulnik)².*

Es bueno estar preparado de antemano, pero una vez impactado por un trauma no es demasiado tarde para cultivar la capacidad de salir adelante de manera resiliente (Dennis Charney)³

Hace hoy, 27 de Agosto del 2020, 53 años de la muerte imprevista e impredecible de un hermano mío a los 23 años de edad. Este acontecimiento dejó en la familia una herida nunca cerrada en madre y mal cicatrizada en todos los hermanos. En mi madre esa herida sangraba con frecuencia, cuando los gritos de mi hermano muriéndose a 12 metros de ella pedían una ayuda que nadie pudo dar... En los hermanos, cada año y ya son muchos los que han pasado, esa cicatriz mal cerrada nos muerde, re-muerde y convoca a la oración y a pedir perdón como si fuésemos culpables de alguna forma de aquel acontecimiento traumático sobre cuya causa nunca quisimos indagar....

Casi 10 años después, murió mi padre. Era un 6 de Enero. Fiesta de Reyes en España. En mi familia, en el año 1977, tal vez el día de mayor festejo navideño. Era el día en que mi padre cantaba, desde el coro, en medio de la ventisca de nieve invernal, desde el coro de la Iglesia, una canción que paralizaba

² Psiquiatra francés de origen judío. una de las personas que más han contribuido a la comprensión de la resiliencia a partir de su propia experiencia de niño traumatizado. Autor de Los patitos Feos, La psicoterapia de Dios y otros veinte trabajos explicativos de la resiliencia desde óptica multidisciplinar: psiquiatría, neurología, etología, psicológica, etc...

³ Dennis Charney, un investigador de la resiliencia y decano de la Facultad de Medicina Icahn del Hospital Monte Sinaí, en la ciudad de Nueva York, salía de una tienda de alimentos cuando recibió un balazo de un expleado insatisfecho. Charney pasó cinco días en terapia intensiva y tuvo una recuperación difícil. "Después de 25 años de estudiar la resiliencia, yo mismo tuve que ser resiliente", dijo Charney, coautor del libro *Resilience: The Science of Mastering Life's Greatest Challenges*.

a los asistentes: *Palmas de Belén que mueven airados los furiosos vientos que suenan tanto: no le hagáis ruido, corred más paso, que se duerme mi niño, tened los ramos.*

Ese día, después de 4 meses de haber sido intervenido para colocarle 4 bypass en operación a corazón abierto, convocó a todos los hijos e hijas con sus respectivas familias para el almuerzo de Reyes. A mí, que estaba lejos, me llamó por teléfono. Fue la primera, única y última vez que lo hizo.

Murió poco después de la comida familiar. Desde entonces, ese día, durante muchos años, el día de Reyes ha sido la fecha navideña más bonita.

.....

Ayer, 26 de Agosto, murió en Maracaibo un amigo mío de Machiques. Era mi compadre, Enmanuel. Se lo llevó el virus de la pandemia en 30 días. De manera increíble, aunque previsible. En la noche anterior, hablando con su esposa, compartimos las buenas noticias que abrían expectativas de que saliera vencedor. A la mañana siguiente, temprano, la noticia: la muerte, la dama del alba, como la describió Alejandro Casona, lo arrancó de cuajo. Esposa viuda y tres hijos huérfanos.

La memoria familiar hizo una marcha atrás vertiginosa a 32 años antes. La misma escena: el papá de tres de las hermanas había muerto de manera trágica dejando a la madre viuda y tres niñas huérfanas... La noticia de la muerte de Enmanuel hirió dos veces.

La tragedia de su abrupta partida y, como la resonancia de un eco, la reapertura de una herida que, aunque bien controlada y bien encriptada, si bien con algunas fisuras que actuaban como válvulas de descomprensión, nunca pudo ser ni bien ni totalmente cicatrizada. Dos golpes a la vez. El segundo, el del 26 de Agosto, se vive en el presente como un trauma cuyo impacto ya se conoce y se proyecta como amenaza futura que repite una pasada paseidad (expresión de Ricoeur, para hacer referencia a una realidad pasada –sufrida - en el pasado...). *¿Cómo ayudar a los niños a tejer su pasado, con el presente y con un futuro que, a continuar un nuevo desarrollo después del trauma psíquico que hoy les golpea?*

.....

El 20 de Junio una amiga de Cumaná chateaba conmigo sobre el Covid'19. Teníamos nuestras dudas sobre si la información del Gobierno sobre los casos de infección por el Covid en el Estado Sucre serían verídicos o no. *No conocíamos a nadie con Covid: "No sé lo que pensar sobre la pandemia... A veces creo que es mentira todo esto. No conozco a nadie que lo haya tenido..."*

El 1 de julio me dijo: *Estoy muy mal. Mi esposo Edu está en terapia intensiva.* El día 8 de julio, cuando una vez más le pregunté como estaba ella y cómo seguía mi amigo Edu, me respondió: *Edu está guerreando por la vida... Yo no importa, al lado de mi esposo, con esperanza y fe.*

El día que le dijeron que su esposo tenía Covid 19, tuvo que irse a la casa dejando las adyacencias del hospital para que no le llevaran a ella a un refugio de mala muerte por presunto contagio de Covid....

Su esposo fue visitado por la madrugadora dama del alba después de 20 días, justamente cuando su esposa pensaba que iba a ganar si no la guerra definitiva, sí esta batalla. Mi amiga y el hijo de los dos, casi entrando en la adolescencia, están en duelo desde entonces, encerrados físicamente por la

cuarentena pero, espero, que acompañada por toda la red de amigos y amigas que ha tejido a su alrededor... *Pero, ¿cómo toda esta red puede convertirse en una tutoría de resiliencia?*

Juan era el padre de una vecina mía. Sus otros hijos, los tenidos con la madre de mi vecina, se han ido fuera de Venezuela, consecuencia de esta historia reciente de expulsión de venezolanos provocada por la amenaza del hambre y por la estrechez de libertad... De este matrimonio de Juan con su primera esposa sólo una ha quedado anclada en Venezuela con tres niños pequeños. Es Ana.

Su padre era todo para ella. La hija mimada y consentida. No porque ella lo diga. Yo lo veía cada vez que Juan se acercaba a la casa y a mi amiga y vecina le brillaban los ojos..., Ana y sus niños pequeños, los nietos de Juan, por varias dificultades no han podido salir del país para encontrarse con el esposo que hace unos meses ya salió para Uruguay.

De repente me llamó y me dijo: *Mi padre está en la UCI del hospital. No quería ir...* El 26 de julio lo entubaron. El 31 de julio murió....*Una situación bastante fuerte para mí... Ni siquiera lo pude despedir... Sólo desde el carro le pude decir adiós. Veía la muerte por Covid lejos, nunca la pensé cerca... Ya no lo tengo a él.... Mi papá se fue muy joven, con él yo contaba....*

Su primer esposo ha muerto años atrás, asesinado, cuando sus hijos morochos apenas tenían 8 días de nacidos ... Su segundo esposo está lejos, se tuvo que ir a trabajar en Uruguay. A su padre se lo llevó la Covid... ¿Cómo vivir este duelo?

.....

Estas historias que he contado, comenzando por la de mi familia, me han llevado a preguntarme si valdría la pena o no escribir algo sobre el duelo en tiempo de Covid. De repente me decidí a hacerlo. Desde hace unos días, como ya algunos saben, estoy tratando de organizar, con mis conocimientos en psicología social, algo de información para poder abordar la resiliencia – la palabra de moda del siglo XXI y, por tanto, con el riesgo de ser desgastada por tanto ab-usarla - en situación de Emergencia Humanitaria Compleja, desde una perspectiva transdisciplinar y, posteriormente tratar de encontrar algunas vías de investigación convivial con relatos de historias de vida...

En esta tarea estaba cuando recibí la noticia de la muerte de mi compadre Enmanuel. En ese preciso momento estaba leyendo algo escrito por Boris Cyrulnik⁴, el niño francés que a los seis años escapó de una sinagoga donde los nazis le tenían prisionero junto con otros niños judíos, escondiéndose primero en un baño y después debajo del cuerpo de una mujer mediomoribunda, y de este modo evitó ser llevado a los campos de concentración donde sus padres habían muerto.

⁴ Boris Cyrulnik, *¿Por qué la resiliencia?*, en Boris Cyrulnik, Marie Anaut (Coords.), Gedisa, 2016

Desde entonces, quiso ser psiquiatra para comprender el nazismo y su horror...hasta que sólo más tarde, ya psiquiatra renombrado, se dio cuenta que la psiquiatría no era capaz de ayudar a comprender el horror vivido...

Pero sí le ayudó a comprender cómo fue que él, un niño cargado con un trauma que inexorablemente debía llevarlo a la muerte psíquica, se convirtió en un sobreviviente, siguió viviendo e inició un nuevo desarrollo. Desde entonces, es el psiquiatra, neurólogo, etólogo de la resiliencia. Escribo algunas de las citas que estaba leyendo en el momento de recibir la noticia.

Podemos hablar de resiliencia familiar cuando, después de un desgarramiento traumático, la familia recupera un funcionamiento tranquilizador, se distancia del sufrimiento y es capaz de transformar el trauma en historia del pasado y en actividades que se pueden compartir(...)

Las familias cerradas, rígidas, se revuelcan en sus sufrimientos, haciendo imposible la reestructuración del trauma. Se instaura una no-vida en la familia, en la que todos callan para evitar la explosión.

Mientras que las familias abiertas a la vida social y compartida con amigos son capaces de hacer evolucionar los vínculos desgarrados por el sufrimiento. Inventan rituales nuevos (vacaciones, cumpleaños) y reorganizan otro funcionamiento resiliente (...).

Estos períodos sensibles (niñez, adolescencia y tercera edad) arrojan luz sobre la importancia de la estructura del medio que estructura el mundo íntimo: un aislamiento sensorial precoz – durante los primeros años - crea una vulnerabilidad neuroemocional que dificulta las relaciones y el aprendizaje, hasta el punto de conducir al adolescente a la depresión.

*Y en los mayores, un trauma no resiliado, que nunca ha sido elaborado ni reestructurado, una negación que inicialmente evitó el sufrimiento («todo eso ya pasó», «hablemos de otra cosa») **resurge «como si acabara de pasar».***

Tres períodos sensibles en toda historia de vida subrayan la importancia del medio afectivo y del contexto cultural. En el recién nacido, el nicho sensorial que impregna en el cerebro la adquisición de un factor de vulnerabilidad o de resiliencia halla su origen en el afecto de los padres, en la historia de su vida y en las organizaciones sociales.

Los adolescentes que llevan a cabo bien el viraje de su existencia han recibido seguridad durante la infancia. Adquieren confianza en sí mismos y encuentran en su entorno estructuras sociales y culturales que tutorizan su nuevo desarrollo.

Los mayores que hayan podido, durante su vida adulta, elaborar su trauma, compartir el relato de sus desafíos y reestructurar la representación de su malestar, no padecen este resurgimiento traumático y no transmiten su malestar al haber modificado su memoria.

Continua (segunda parte)

II.- ¿CUÁLES SON LAS FUENTES DE RESILIENCIA PARA BEBÉS Y NIÑOS PEQUEÑOS EN DUELO POR LA MUERTE DE UN SER QUERIDO?”

Hélène Romano⁵

Extracto, con explicaciones más entre paréntesis, con la intención de hacer más fácil la comprensión de algunos términos de psicología y psicoanálisis (Abilio López Pérez, 27-Agosto-2020)

A modo de preámbulo:

Nuestra práctica clínica (...) nos lleva a intervenir de urgencia desde los primeros momentos posteriores al anuncio de la muerte (...) en el marco de un seguimiento psicoterapéutico de bebés, niños, adolescentes y adultos expuestos a acontecimientos traumáticos intencionales o accidentales.

El sufrimiento traumático provocado por la brutal pérdida de los padres fue descrito hace tiempo (Freud y Burlingham, 1943; Winnicott, 1974; Bowlby, 1973), pero sigue siendo mal conocido y suscita múltiples controversias.

Nuestro trabajo con niños en duelo a causa de la pérdida violenta de un pariente cercano (padre, madre, hermanos) nos lleva en efecto a constatar la dificultad de los intervinientes y del entorno del niño para pensar la realidad del impacto traumático de esta pérdida, algo indispensable para sostenerlo en este duelo precoz (Romano, 2006, 2012).

La indiferencia, la banalización, incluso la negación de la realidad del sufrimiento de los bebés y de los niños pequeños en duelo son frecuentes. En efecto, el dolor de bebés y niños, ya sea físico o psíquico, no es fácil de admitir y se tarda en compartirlo. Aún es más evidente en el caso del dolor psíquico y, en especial, el dolor traumático y el dolor del duelo.

Frecuentemente se oye que los niños pequeños no se dan cuenta de lo que están viviendo, que son demasiado pequeños para entenderlo, que lo olvidarán fácilmente cuando se hagan mayores, que lo convierten todo en un juego, que no acumularán las huellas violentas en su memoria, que no disponen de metacognición (capacidad de recabar, producir y evaluar información) e introspección (capacidad de hacer consciente la experiencia sensorial, afectiva o imaginativa) suficiente, que no poseen una representación suficiente de la muerte y, por lo tanto, no tienen miedo de ella, que la conciben como algo transitorio (papá o mamá están de viaje) y no pueden establecer la conexión entre el acontecimiento violento y la muerte real e irreversible... Estas aserciones se basan en datos parcialmente verdaderos, **pero la consecuencia que se extrae de ellos es errónea. (Por ejemplo:)**

- En opinión de algunos autores como Anna Freud (la hija de FREUD, el creador de psicoanálisis), mientras el niño (...) no tenga las capacidades cognitivas (capacidades de percibir, memorizar y poner palabras) suficientes para entender el sentido de la muerte, no puede estar en duelo (en sentido del psicoanálisis: dolor por la despedida del ser querido, pero desatadura y liberación para construir el futuro; diferente a la melancolía, que es atadura al

⁵ <http://ilera.com.mx/wp-content/uploads/2019/11/%C2%BFPor-qu%C3%A9-la-resiliencia-Lo-que-nos-permite-reanudar-la-vida-Spanish-Edition.pdf>

dolor del pasado sin abrirse hacia el futuro) y es incluso incapaz de llevar a cabo el trabajo de duelo (despedida dolorosa, sí, pero sin quedar atado).

- No es infrecuente que (algunos utilicen el) concepto de **resiliencia** para justificar esta negación de la realidad del duelo en los pequeños y sus consecuencias. De esta forma (se puede llegar a pensar de manera errónea) que el niño puede soportarlo todo «gracias» a la célebre resiliencia (como si fueran niños de oro, invencibles, invulnerables, superdotados por naturaleza).

Una lectura más acertada de las aportaciones de la resiliencia (Cicchetti y Rogosh, 1997) muestra que, frente a un acontecimiento traumático, el niño está en disposición de movilizar sus recursos internos (si durante los primeros meses tuvo una familia, una madre o padre o abuelos o tíos o tías o tutores de desarrollo que le produjeron seguridad) en función de la calidad anterior de los procesos interrelacionales con su entorno, así como de la calidad de los procesos interrelacionales posteriores al acontecimiento (si después de la herida que produce el golpe de la muerte – pues el niño no es invulnerable - sigue encontrando tutores de desarrollo con quienes mantener vínculos de apego que le den aseguración).

Dicho de otro modo, si el bebé en duelo se ha beneficiado con anterioridad de interacciones tranquilizadoras y estructuradoras y si adultos con capacidad de tutorizar su desarrollo se hacen cargo de él (...), las consecuencias traumáticas serán menores que en el caso de que se encuentre solo en el mundo y sin los recursos adquiridos (son los de los vínculos de apego que le dan seguridad)

En opinión de autores como Bowlby (el creador de la teoría de apego) y otros, el «trauma de la pérdida» no tiene edad y el niño pequeño no es ajeno a él, más bien al contrario (...). De esta forma, la realidad del duelo en el niño pequeño ha sido confirmada por parte de numerosos equipos de especialistas (...) en el tratamiento de acontecimientos traumáticos en los niños (Lieberman et al., 2003).

Nuestra experiencia con niños pequeños y bebés expuestos a muertes y a duelos traumáticos nos lleva a afirmar que, precisamente, el duelo es traumático debido a la vulnerabilidad psíquica del niño. La ausencia de mecanismos emocionales operativos y su inmadurez neurocognitiva (todavía no conformada la red de neuronas cerebrales que captan y transmiten las sensaciones para convertirlas en conocimientos) no le permiten elaborar las consecuencias de la muerte como lo haría un niño mayor o un adulto.

El pequeño pierde violentamente todos los puntos de referencia que estructuraban su forma de interaccionar con el mundo exterior. La muerte de uno de los padres durante la infancia temprana (entre 0 y 2 años) resulta tan psíquicamente desestructurante para el niño, que no está capacitado para entender el sentido de esta pérdida. La muerte de uno o de ambos padres representa la pérdida brutal de un sentimiento de seguridad y de bienestar a una edad en que el niño no es capaz de elaborar el sentido de esa brutal desaparición. Según Bowlby y otros autores, este cataclismo íntimo le provoca un estado de agonía psíquica que conduce a una ruptura en la continuidad de su sentido de sí mismo (...), capaz de hipotecar su porvenir de forma duradera.

Hemos comprobado que la muerte violenta de alguien cercano y sus consecuencias rompen su ritmo de vida, hacen pedazos su confianza en la vida y en quienes son responsables de ella (sus figuras de apego: abuelos, tías, hermanos, vecinos, etc.). Los bebés y niños pequeños no disponen de una representación completa de la muerte, **pero sí que poseen, desde muy temprano, una representación de la vida.**

A estas consecuencias directas de la muerte hay que añadir las consecuencias indirectas, es decir, las consecuencias, sobre estos niños, de los traumas paternos o colectivos. En efecto, los niños —y en particular los más pequeños— necesitan para vivir y crecer la ayuda de sus padres o de sus sustitutos, tutores de desarrollo o bien de un grupo (...).

(Pero, ¿qué ocurre si el padre o la madre que quede vivo o la familia o los tutores de desarrollo quedan traumatizados por la muerte del otro u otra?)

... unos padres traumatizados y un grupo desestructurado por acontecimientos colectivos están demasiado heridos psíquicamente para estar lo «suficientemente» disponibles (...) para su hijo y para ocuparse de él de una forma adaptada. Su propio dolor, sus miedos, sus sentimientos de culpabilidad y de impotencia pueden hacer que se encuentren, de forma continuada, en una mala posición para desarrollar sus competencias paternas, por lo que dejan a su hijo solo ante el duelo.

.....

Cómo afecta la muerte de uno de los padres

La muerte de uno de los padres puede sobrevenir en una multiplicidad de contextos que es preciso conocer, puesto que las circunstancias de la muerte inciden en el niño: cuando la muerte es esperada - por enfermedad, por secuelas de un accidente - los adultos normalmente elaboran un «preduelo» (...) y no se encuentran en el mismo estado de fractura psíquica que en el caso de una muerte inesperada. Las repercusiones de la muerte en la vida cotidiana del niño a menudo son anticipadas, en particular por la presencia obligada junto al niño de la persona que sustituirá al padre desaparecido. Esta preparación permite limitar al máximo las perturbaciones proporcionando al bebé, lo antes posible, una continuidad material y afectiva necesaria.

En el marco de una muerte accidental o por causas médicas inesperadas (como por Covid, por accidente, por infarto, por homicidio, etc), los adultos se ven violentamente golpeados por esta muerte repentina, de modo que no pueden tranquilizar al niño ni asegurarle la continuidad de cuidados indispensable para su vida cotidiana.

Otro caso es el de un padre muerto a causa de un suicidio. A la fractura psíquica ligada a la brutal confrontación con la muerte de un ser querido, se le añade la intensa culpabilidad de sus allegados. Cuando crecen, es frecuente que los niños que hayan pasado un duelo en su más tierna infancia debido a tales circunstancias expresen a su vez una culpabilidad muy fuerte y se atribuyan una responsabilidad por esa muerte. Cuando sobreviene el suicidio, los allegados a menudo esconden las causas de la muerte y minimizan todo aquello que el niño haya podido ver y escuchar; en particular, cuando éste se encuentra presente en el momento del suicidio o del hallazgo del cadáver. El niño sabe qué ha ocurrido, aunque no tenga una comprensión adulta de los hechos, y las mentiras que se vierten sobre este acto hacen más frágil su confianza en el adulto de forma duradera.

Un contexto diferente es cuando el niño es testimonio directo de la muerte de su progenitor (suicidio, accidente, homicidio, guerra). El terror sentido frente al acontecimiento crece a causa del desconcierto ante el cuerpo sin vida de su padre o de su madre: esa madre o ese padre que ya no responden, que no se mueven y que a menudo están irreconocibles por las heridas que les han causado la muerte. Muertes como éstas exponen violentamente a los testigos, pequeños y mayores, a estímulos extremos (sonidos, olores e imágenes) capaces de quedar impresos de forma duradera en la memoria y provocar múltiples reviviscencias.

El impacto sensorial puede aumentar debido a otros estímulos que acompañan a la muerte, principalmente las llamadas de ayuda y los gritos de los testigos. Estas consecuencias se describen en la literatura que habla de los adultos que han sido víctimas de acontecimientos traumáticos, pero raramente hacen referencia a niños, aunque éstos no se encuentran a salvo y tales escenas pueden quedar grabadas durante mucho tiempo en sus mentes. En estas circunstancias, calificadas como duelo postraumático, (...) a la herida del duelo se le pueden añadir trastornos postraumáticos ligados al enfrentamiento violento con la muerte de su progenitor. Su pérdida queda inextricablemente ligada a todo el contexto traumático y el recuerdo puede hundir al niño en una angustia extrema.

Por parte del clínico (el psicólogo o especialista), la atención debe centrarse a la vez en los trastornos postraumáticos que surgen tras el acontecimiento y también en los trastornos ligados al duelo —lo cual no es nada fácil—. (...)

Sea cual sea el contexto de la muerte, la conmoción en la organización familiar también puede ocasionar nuevas tensiones y exponer al niño a otros conflictos. Los reproches entre adultos sobre las responsabilidades de unos y de otros en las causas de la muerte, las decisiones que se toman acerca de las modalidades de custodia del niño y la reactivación de conflictos familiares anteriores también son factores que influyen en la inseguridad del niño y pueden empeorar sus trastornos (Pynoos, 1993).

Las posibles reacciones del pequeño en duelo

La literatura nos recuerda que las repercusiones psicotraumáticas de una muerte dependen al mismo tiempo de factores internos - nivel de desarrollo psicoactivo y cognitivo del niño en el momento de la muerte- , pero también de factores externos - forma de la muerte, presencia o no del niño durante la muerte, reacciones de sus allegados, etc -. Los síntomas más frecuentemente descritos en el niño pequeño son estados de postración, atonía tímica (**pérdida de fuerza muscular por disfuncionamiento de la glándula del timo**) y retracción emocional (retraimiento social y guarda de emociones para sí mismo, lo que puede parecer como falta de dolor por la muerte del ser querido), tristeza profunda, pérdida del interés por el juego, trastornos del sueño - hipertonía (**rigidez muscular excesiva, cuyo origen está en el sistema nervioso alterado**), pesadillas, negativa a dormir solo - , accesos de cólera que se manifiestan mediante crisis clásticas (**crisis fragmentadas, como romper vidrios, tirar objetos al suelo, etc**), ansiedad (angustia sentida ante la percepción de un peligro imaginado o inconsciente; mientras que el miedo es angustia o preocupación ante la percepción de un peligro real) ante todo aquello que pueda recordar la pérdida - principalmente separaciones, aunque sean por poco tiempo, de sus nuevas figuras de apego - , manifestaciones de cólera y comportamientos agresivos, regresión del funcionamiento del desarrollo (**el retorno a posiciones de desarrollo anterior que le fueron y siguen siendo confortables y por eso quedaron como “lugares” de refugio cuando resulta difícil afrontar**

situaciones difíciles o desagradables: el desarrollo es como una procesión que va hacia adelante, con pasos de avance y retroceso....).

Estos síntomas pueden agravarse por trastornos postraumáticos si el niño estaba presente: reviviscencias, juegos traumáticos (actividades repetitivas que privilegian las temáticas de agresión, miedo o indefensión durante el juego y que, con mucha probabilidad, producen un efecto de re-traumatización), hipervigilancia si el niño quedó directamente expuesto a la muerte del progenitor.

La especificidad de estos trastornos en el niño estriba en que pueden ser de corta duración y resurgir de forma episódica, interrumpidos por momentos en los que el joven se ocupa del mundo exterior «como si nada hubiera pasado». Wolfenstein propuso el término de **short sadness span** (breve lapso de tristeza) para describir estos períodos de pausa, cuya explicación sería la incapacidad del niño para soportar por mucho tiempo la angustia. (Pero) para los adultos de su entorno, estas reacciones, que podríamos designar como «manifestaciones intermitentes del duelo», son particularmente desconcertantes. Las fases de desesperación intensa dan paso a períodos de aparente indiferencia, que hacen creer al entorno del niño en duelo que él no ha quedado tan «tocado» como los adultos.

Fuentes de resiliencia y perspectivas de cuidado

(...) Uno de los factores principales de resiliencia es que estas manifestaciones postraumáticas sean reconocidas por su entorno y que puedan ser elaboradas por parte de las nuevas figuras de apego del niño. La negación de la realidad del duelo es una causa de mayor victimización.

Aquí subrayamos las dificultades a las que se enfrentan los adultos que velan por el niño ante los trastornos que éste presenta:

(los adultos) se pueden sentir desorientados, molestos, enervados, impotentes e incompetentes ante manifestaciones que no consiguen calmar. El riesgo principal es la negación de lo que representan los trastornos (por ejemplo, «tiene rabietas», cuando el niño presenta una crisis de reacción clásica ante las reviviscencias traumáticas).

Para reforzar el factor de resiliencia que representa el reconocimiento de las manifestaciones de duelo en el pequeño, nos parece esencial apoyar a los adultos que se ocupan del niño.

- Al tratar a un niño, ciertos puntos merecen ser abordados con precisión: la necesidad de asegurar, con el bebé o el niño, una continuidad de los cuidados, con una figura de apego de sustitución estable.
- Es importante considerar la importancia de darle al bebé pertenencias de la persona muerta (vestidos con su olor) y conservar huellas materiales (fotos, objetos personales y vídeos), y ello debe hacerse rápidamente, desde los primeros días posteriores a la muerte, antes de que se lleve a cabo alguna «evacuación» (retiro de una persona de un lugar): a menudo la temprana edad del niño hace pensar a las personas de su entorno que no tiene sentido conservar las pertenencias personales del progenitor muerto: «Es demasiado pequeño para que esto tenga valor alguno para él»; «No se acordará de nada ¿para qué guardar todo esto?», «Le hará más daño que bien».
- A esta edad, en que los niños no disponen de los recursos psíquicos suficientes para memorizar las representaciones internas de la persona desaparecida, prestar atención a todo aquello que

pueda recordarle a su progenitor es más que necesario. El seguimiento de niños y adultos en duelo confirma hasta qué punto todas estas «huellas» son esenciales y preciosas para soportar la ausencia del progenitor.

- (Inmediatamente después de la muerte), las personas de su entorno tienen dos preocupaciones principales: el anuncio de la muerte y la participación en los rituales funerarios.

....(Hay que cuidar que) que la explicación de la muerte del progenitor se dé mediante palabras sencillas. Los bebés son más sensibles a la tonalidad emocional de lo que se les dice que al sentido literal de la información. El modo en que se fijan en el adulto que les habla o cómo interrumpen lo que estaban haciendo para movilizar toda su atención hacia quien los interpela muestran la importancia de hablarles y explicarles lo que acaba de suceder.

Hay algunos puntos que es preciso transmitir al niño, adaptando, según su edad, nuestro vocabulario: el padre o la madre ha muerto; ya no volverá; ya nunca podrá estar con él como antes, pero no será olvidado; el progenitor muerto ya no sufre; él no es el responsable de la muerte de su progenitor; él no corre peligro de morir; no está solo, sino rodeado de personas que le quieren y que van a ocuparse de él lo mejor posible; puede continuar amando a su progenitor muerto y pensando en él.

La presencia del bebé o del niño en las exequias hay que considerarla con cada familia, teniendo en cuenta los recursos de cada una y, en particular, su disponibilidad a su lado durante la ceremonia. Si no puede estar presente, puede participar de otra forma en los rituales de duelo (por ejemplo, con una foto, el regalo de un objeto transicional o juguete para poner junto al cuerpo del progenitor, etc.).

También es importante que el niño pueda materializar la muerte de su allegado en un lugar (tumba, lugar donde se han esparcido las cenizas, etc.) al que pueda acudir.

Conclusión:

La muerte de uno de los padres en la infancia temprana es un acontecimiento traumático considerable que puede hipotecar el futuro de un bebé. La atención que se presta a los bebés y a los niños muy pequeños en duelo es, aun hoy en día, limitada, y a menudo se le quita importancia a su angustia. Sin embargo, tras el horror de la pérdida de uno o ambos progenitores, este bebé o este niño pequeño en duelo deberá continuar viviendo.

Los duelos en la infancia temprana pueden llevar a mentiras, secretos, silencios que son cada uno un «fantasma» que puede visitar la habitación de estos niños (...) y estar presente en su vida adulta.

Acompañar a las personas del entorno encargadas de estos niños (familia, profesionales) y prestar atención a estos pequeños y a las expresiones particulares de su tristeza son también maneras de limitar las transmisiones traumáticas intergeneracionales.

Proporcionarles un cuidado precoz, lo antes posible, tras la pérdida del progenitor, nos parece esencial para prevenir trastornos postraumáticos y trastornos psíquicos resultantes del duelo.

El futuro de estos niños también puede inscribirse en un porvenir posible, rico en recursos internos liberados y respetuosos con la singularidad de su historia. Pero para ello la realidad del duelo en la infancia temprana debe ser reconocida y tomada en consideración. También es necesario inscribir

estos cuidados en un tiempo concreto (lo antes posible después de la muerte, en los primeros días y meses que siguen) y que luego estén disponibles durante los años posteriores.

En efecto, los seguimientos terapéuticos nos permiten constatar que ciertos períodos de la vida son particularmente propicios para la reactivación de acontecimientos traumáticos pretéritos: la adolescencia, el embarazo, el nacimiento de un niño y la llegada de un hijo a la misma edad en que se produjo el trauma. Estas reactivaciones pueden llevar a verdaderos colapsos psíquicos que se pueden anticipar gracias a un trabajo terapéutico previo.

El hecho de prestar atención a estos niños pequeños en duelo es también lo que constituye el primer acto de restauración psíquica. Si esta mirada es fuente de estigmatización y de condena del niño por su condición de huérfano, él no será capaz de construirse dentro de un vínculo humanizador con el otro. El proceso de resiliencia que permitirá a estos jóvenes en duelo seguir viviendo pasa por el reconocimiento de su historia traumática dentro de un vínculo en el que el otro lo reconozca como sujeto de su historia, de esa historia, y le dirija una mirada de confianza, llena de esperanza, sin negar su pasado (Cyrulnik, 1999, 2012)